

NS			
MARIA APARECIDA MITSUE WAKI DA SILVA			
IDADE: 65 anos	PESO: 65 kg	ALTURA:	PROFISSÃO: de lar
SINTOMAS:			
QUEIXAS: dorme bem			
MEDICAMENTOS: HAS (Amlodipina, Nifedipina), DM (metformina 1-850mg); Hapiinol (ác. úrico): glaucoma - colírio			
EXERCÍCIO FÍSICO: - não está fazendo -			
HORARIO DAS REFEIÇÕES - CAFÉ: S ALMOÇO: S LANCHE: S JANTAR: S			
HORA QUE DORME: 22h30' - 23h		HORA QUE ACORDA: 6h	
COCHILHO () SIM (X) NÃO		DORME ACOMPANHADO (X) SIM () NÃO () EVENTUAL	
BEBIDA ALCOÓLICA (X) SIM () NÃO NA SEMANA () NÃO nenhum - às vezes.			
FUMO () SIM () MAÇO/DIA (X) NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO:			
TIPO DE RESPIRAÇÃO: boca		BANHEIRO: 1x noite	
CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL:		CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO: 43cm	
OVERLAP: sim	MALLAMPATI: IV	IAH:	SPO2:
PATOLOGIAS ASSOCIADAS:			
CIRURGIAS: (X) NASAL () AMIGDALECTOMIA			
HIPOVENTILAÇÃO DA OBESIDADE:			
COMORBIDADE: (?) RESPIRATORIA (S) ENDÓCRINA (N) CARDÍACA			
(N) ORTOPÉDICA (N) NEUROLÓGICA () OUTROS			
17/04/23 não acordou hoje em dia sente falta de ar (já tinha 4 doses) que tem gripe/quadro alérgico			
Exala	Qualidade Sono	9	
	boca seca	5	
	lerantar/desperto	10	
	banhado	10	
	comerso	10	cont →
24/05	P = 10.7 cmH ₂ O		
23	IAH = 1.1 e/3v		fuga
	m. de uso: 6h25'		sem adapt.
19/06	P = 10.9 mediana - P95% 13.		
23	IAH = 1.42 e/2v		
	m. de uso: 6.5 horas		fuga.
	Fuga = 1.2 l/min		
21/08/23	P = 10.1 - P95%: 10.3		→ K fazendo caminhada todo dia 2x
	IAH = 1.6 e/2v		
	m. de uso: 6h14 min		
	fuga: 20 l/min		
	Auto: 8-10.4 cmH ₂ O.		
	FR: normal - 2.		* flocos finos
23/10/23	P = 10.1 P95%: 10.3		
	IAH = 1.7 e/2v		
	m. de uso: 6h20'		
	fuga: 21 l/min		
	- operou catarata - não está usando por 5 dias		
	- vai operar - mastectomia E → Ca		
			* ao cheio

08/01 P: 40 cmH₂O P_u 95: 40,3
2024 IAH = 1,3 e/h
m de uso: 6h30'
fuga: 23,5 l/min

31/10 fez mastectomia Eq.
esvaziamento axilar

Amamã 09/01 - vai nova
abordagem residual mama

08/03 P: 9,9 cmH₂O percentil: 10,3
24 IAH = 1,4

m. de uso: 6h13'
fuga: 5,9 l/m

Fará cirurgia de
catarata no olho
esquerdo no dia
15/03 e ficará 1 semana
a utilizar o cpap

Natasha

08/05/24 P: 8-10,4 cmH₂O mediana 9,9 cmH₂O

IAH = 0,5 e/h

m de uso: 6h5m

fuga: 2,9 l/m (mediana) (faltam 10 sessões)

Natasha

10/07/24 P: 8-10,4 cmH₂O

IAH = 1,0 e/h

m de uso: 5h44'

fuga: 35,2 l/m

Bem adaptada

Natasha

11/09/24 P: 10,0 cmH₂O

IAH = 0,6 e/h

m uso = 6h21

fuga: 28 l/min

Boca seca

Auto: 8 à 10,3 cmH₂O

Bem adaptada

* hoco filtro * siena

13/11/24

P: 9,9 cmH₂O

IAH = 0,6 e/h

m uso = 6h19 min

fuga: 31 l/min

Acorda 2x banheiro

refere despertar d
mta penas au no
nariz

Auto 8 à 10,4 cmH₂O

→ 8 à 10,0 cmH₂O
siena

15/01/25

P: 9,6 cmH₂O

IAH = 0,8 e/h

m uso = 6h21 min

fuga: 34 l/min

Boca seca

09/04/25

P: 9,7 cmH₂O P_u 10: 10 cmH₂O

IAH = 0,8 e/h

m uso = 6h32 min

fuga: 30 l/min

despertando d escape

* hoco filtro * hoco big Almofada ⑤ *
sift

siena

m^s Aparecida Mitre

07/2025 P: 9,9 cmHg

Auto 8 a 10.

IAH = 0,8 e/h

muco = 6h21

fugr = 11 min

* nao filtro

MARIA APARECIDA MITSUE WAKI DA SILVA

MEDICAMENTOS:

SINTOMAS/QUEIXAS

BANHEIRO

HORA QUE ACORDA

HORA QUE DORME

PRÁTICA EXERCÍCIO

HORARIO DAS REFEIÇÕES

CAFE:

ALMOÇO:

LANCHE:

JANTA:

21/10 Não consegue se adaptar ao CPAP.

22 Relata que sente falta de ar

25/10 P = 14.1 cmH₂O

22 IAH = 5.7 l/h

Fuga = 5.7 l/min

Relata ↓ edema em mmII.

Melhora da sonolência diurna intensa

Melhora do peso na cabeça

Odo saía de ômbros dormia e acordava em outro Bairro, pois as pernas das mães.

Não assistia TV.

Cansaço (nota 5) / Qualidade de sono (7)

Boca seca (7) / Banheiro (8) / Despertares noturnos (10x)

Ficou sonolenta na 18 anos (em 2002).

04/11 P = 14.0 (média = 11.1)

22 m. de uso: 5h36'

Fuga = 10.7 l/h

IAH = 4.6 l/h

Melhora do edema (n. encha mais)

Acabou o peso na cabeça, durante o dia

Tira 30', consegue assistir TV.

Qualidade do sono - 9

Cansaço - 10

Boca seca - 7

despertar a noite - 2x

banheiro à noite - 2x

11/11 P = 13.6 cmH₂O

22 IAH = 4.0 l/h

m. de uso: 5h50'

Fuga = 12.0 l/h

Dorme: 22:30 - (acorda) 6h

→ Dor de cabeça ↓

↓ 1 Kg.

↓ edema mmII

Banheiro 2x

Qualidade do sono 9

Cansaço 9

Boca 7

Despertares 2x

17/11 - Biologix = 38% IDO - Tempo de spO_2 16%

21/11 - P = 13,3 cm H_2O

22 IAH = 2,6 l/min (IA = 2,6)

Fuga = 14 l/min.

12/12 Passou em consulta, e $\downarrow$ 850mg de metilformina 2x ao dia, e passou p/ 500mg 1x por semana.

Para PA nifedipino 2x/dia / atenolol 1x-a noite.

$\downarrow$ 2Kg de peso, caminha 30' por dia. Relata que está mais disposta e dorme melhor.

M. de uso: 6h20'

P = 13,4 cm H_2O

Fuga = 11,6 l/min.

IAH = 2,9 e/ev

Sua cláudia

13/02 23 P = 14 / 8 max e min. - autom.
mediana 11,4 cm H_2O .

- fuga = 12,5
- IAH = 3,3 e/ev

- Relata melhora da sonolência diurna.

- $\downarrow$ a metilformina p/ 1x - 850mg / anapolinol ácido úrico.

- não tem edema de mm II.

- Qualidade do sono: 8

- Cansaço: 10

- Boca seca: 8

$\downarrow$ 5Kg

67Kg

Caminha de 1h

Despertares not.: 8

Banheiros à noite: 9 (1x)

17/04
2023

Escala

10 cansaço
5 boca seca
10 chontar
10 banheiros
9 qualidade sono

- melhora melhora dispnoia

- Idia CAP sentiu sonolência

$\rightarrow$ formou vacinas

mida uso: 6 horas

Auto P = 8 - 14

mediana P = 11,4

IAH = 2,9

fuga = 2,2 19,2/min

- ficou 2 dias

- da quida $\rightarrow$ ATM mobilizou
formou mioma $\rightarrow$ alergia

- dorme sem prótese dentária

$\rightarrow$ circunferência perçoço

cont $\rightarrow$

Mário Silva Jorge

NEUROLOGIA - CRM 27.123

Membro Efetivo da Academia Brasileira de Neurologia

Membro Titular da Sociedade Brasileira de Neurofisiologia Clínica

Member's of International Headache Society

Prof. em Neurologia - Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP)

Médico do Grupo de Neurologia Cognitiva do HC - FMUSP

A

ANA CLAVIERA

Eucauto a parte

Nome Aparecido M. W. E. E.

9 SAOS - R/ mo

de CATP

Dr. Mário Silva Jorge
Neurologia
CRM 27.123

INEP - Instituto do Cérebro - Clínica da Memória

Rua Santa Clara, 450 - Vila Adyana - São José dos Campos - SP

Telefones: (12) 3921-2071 / 3202-8050 / 3921-4177

Celular: (12) 99125-7193 - WhatsApp

CLÍNICO

DR. ALBERTO REMESAR

DR. ALBERTO JORGE REMESAR LOPEZ

DRO. ELITÂNIA MARINHO PONTES

CRM-SP 69730

CRM-SP 62858

PSIQUIATRIA
**LAUDÔ DA
POLISSONOGRAMA**

NOME: Maria Aparecida Mitsue Waki da Silva

EXAME nº: 5179

SOLICITADO POR: Dr. Mário Silva Jorge

DATA: 18/07/2022

IDADE: 64 anos

Comentários:

Exame iniciado às 21h57min e concluído às 06h02min. A latência para o sono foi de 9 minutos e a latência para o sono REM, de 296 minutos. O tempo total de sono foi de 319 minutos (05h19min), com eficiência de sono (TTS/TTR)* de 67,2%. A distribuição do sono mostrou 51,1% de estágio 1, 45,8% de estágio 2, 0% de estágio 3 e 3,1% de estágio REM. No período total de sono permaneceu 146 minutos em vigília, ocorreram 479 microdespertares (índice: 90,1/hora).

O índice de movimentos periódicos de membros foi de 2,8/hora.

O índice de apneia/hipopneia foi de 104,2/hora, sendo 103,8 apneia/hora e 0,4 hipopneia/hora. O índice de distúrbio respiratório (apneia+hipopneia+RERA) foi de 104,2/hora. A saturação basal da oxi-hemoglobina foi de 92%, sendo a saturação média de 87% e a mínima de 47%.

(*) TTS $\Rightarrow$ Tempo Total de Sono TTR $\Rightarrow$ Tempo Total de Registro

CONCLUSÃO:

Registraram-se aumentos acentuados dos índices de apneia/hipopneia (104,2/hora; índice acentuado: acima de 30/hora) e de distúrbio respiratório (104,2/hora), dessaturações da oxi-hemoglobina, despertares e ritmo cardíaco sinusal. As frequências cardíacas foram: mínima: 59; máxima: 90 bpm.

O ronco foi contínuo e variou de médio a alto.

Ausência de respiração de Cheyne-Stokes.

A paciente adormeceu no tempo esperado (latência para o sono: 9 min; normal até 30 min). A latência para o estágio REM estava alongada (296 min; normal: 70 a 120 min). O sono foi fragmentado pelos despertares longos (eficiência do sono: 67,2%; normal: 85% ou acima) e microdespertares (índice: 90,1/hora; normal até 15/hora). Houve o aumento da porcentagem do estágio 1 (51,1%; normal: 8-10%) e a redução do estágio REM (3,1%; normal: 20%). A porcentagem do estágio 2 (45,8%; normal: 45-55%) permaneceu nos limites da normalidade. Ausência do estágio 3 (0%; normal: 10-12%).

O índice de movimentos periódicos de membros (2,8/hora; índice normal até 15/hora) permaneceu no limite da normalidade. Observei também movimentos de pernas após despertares.

Escala de Sonolência de Epworth: 17 (sonolência diurna; normal até 9; máxima: 24).

Dr. Alberto Jorge
Remesar Lopez
Médico
CRM 69730

Dr. Alberto Jorge Remesar Lopez
Diretor Técnico Médico
CRM-SP 69.730

Flavio Augusto Passarelli Prado

OTORRINOLARINGOLOGIA

100701

Graduação e Pós Graduação pela Faculdade de Medicina da USP
Especialização em Otorrinolaringologia pela Faculdade de Medicina da USP

A Maria Aparecida Mitsue Waki da Silva

Solicito:

- adaptação de CPAP a pressão sugerida de 12cmH2O

G47.3

Dr. Flavio A. P. Prado
Otorrinolaringologista
CRM: 100.701

RECEITUÁRIO

SUS - PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Nº DO DOCUMENTO	000000503836/2021
DATA DO DOCUMENTO	15/09/2021 09:07:55
CRA	000000118316

DE: 0009199 - UBS JARDIM NOVA DETROIT

CIENTE: MARIA APARECIDA MITSUE WAKI DA SILVA

Endereço: AV JOSE FRANCISCO MARCONDES, 149 - JD SAO VICENTE - SAO JOSE DOS CAMPOS CEP: 12224350 CPF: 01933341866

Uso Interno	Código	Termo
* ATENOLOL 25 MG	81141	
- TOMAR 1 APOS CAFE DA MANHA E APOS JANTAR		
* NIFEDIPINA 20 MG - COMPRIMIDO RETARD	7604	
- TOMAR 1 COMPRIMIDO APOS CAFE DA MANHA E APOS JANTAR		
* METFORMINA 850 MG - COMPRIMIDO	47041	
- TOMAR 1 COP APOS ALMOÇO E JANTA		
* ALOPURINOL 300 MG - COMPRIMIDO	7342	
- TOMAR 1 COP APOS ALMOÇO		
* SINVASTATINA 20 MG	83713	
- TOMAR 1 COP APOS A JANTA		

OBS.: MEDICAÇÃO DE USO CONTINUO
MEDIR PA E DEXTRO QUINZENALMENTE

Dr. José Guilherme G. Louzada
Médico
CRM-SP 182.054

JOSE GUILHERME GUEDES LOUSADA
MEDICO DE SAUDE DA FAMILIA
CRM: 182054

Nome: MARIA APARECIDA MITSUE WAKI DA SILVA
Data de Nascimento: 30-7-1957
IMC: 34,24
Sexo: Feminino
Data do exame: 28-09-2022

Peso: 74 kg
Altura: 1,47 m
Médico: DR. FLAVIO AUGUSTO
PASSARELLI PRADO
Medicamentos:
Histórico:

Laudo de Polissonografia para titulação de CPAP

Exame realizado na noite de 28-09-2022, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO2) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

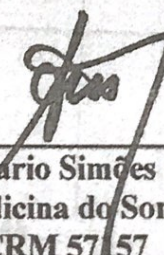
O tempo total de registro foi de 467,0. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 23,5 e 100,5 minutos. O tempo total de sono foi de 324,0, eficiência de 69,4% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 2,8%; estágio N2: 60,3%; estágio N3: 18,4%; sono REM: 18,5%. O índice de despertares foi de 29,2/hora (normal < 10/h).

O índice de apneia/hipopneia total foi de 53,7/hora, sendo elas 162 obstrutivas, 0 mistas e 0 centrais e 128 hipopnéias. A SpO2 média foi de 94% e mínima de 85%, permanecendo 1,7% do tempo de registro com a saturação abaixo de 90%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 55 - 70 bpm e NREM de 56 - 80 bpm.

CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (23), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono reduzida;
2. porcentagem do sono REM diminuída e porcentagem dos estágios N2 do sono NREM aumentada;
3. latências para o sono normais;
4. aumento do número de despertares breves;
5. registro de ronco moderado durante o sono.

Exame polissonográfico para titulação de CPAP com melhor pressão terapêutica de 12 cmH2O.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57157

DR. ALBERTO REMESAR

PSIQUIATRIA
**LAUDO DA
POLISSONOGRAMA**

NOME: Maria Aparecida Mitsue Waki da Silva

EXAME nº: 5179

SOLICITADO POR: Dr. Mário Silva Jorge

DATA: 18/07/2022

IDADE: 64 anos

Comentários:

Exame iniciado às 21h57min e concluído às 06h02min. A latência para o sono foi de 9 minutos e a latência para o sono REM, de 296 minutos. O tempo total de sono foi de 319 minutos (05h19min), com eficiência de sono (TTS/TTR)* de 67,2%. A distribuição do sono mostrou 51,1% de estágio 1, 45,8% de estágio 2, 0% de estágio 3 e 3,1% de estágio REM. No período total de sono permaneceu 146 minutos em vigília, ocorreram 479 microdespertares (índice: 90,1/hora).

O índice de movimentos periódicos de membros foi de 2,8/hora.

O índice de apneia/hipopneia foi de 104,2/hora, sendo 103,8 apneia/hora e 0,4 hipopneia/hora. O índice de distúrbio respiratório (apneia+hipopneia+RERA) foi de 104,2/hora. A saturação basal da oxi-hemoglobina foi de 92%, sendo a saturação média de 87% e a mínima de 47%.

(*) TTS ⇒ Tempo Total de Sono TTR ⇒ Tempo Total de Registro

CONCLUSÃO:

Registraram-se aumentos acentuados dos índices de apneia/hipopneia (104,2/hora; índice acentuado: acima de 30/hora) e de distúrbio respiratório (104,2/hora), dessaturações da oxi-hemoglobina, despertares e ritmo cardíaco sinusal. As frequências cardíacas foram: mínima: 59; máxima: 90 bpm.

O ronco foi contínuo e variou de médio a alto.

Ausência de respiração de Cheyne-Stokes.

A paciente adormeceu no tempo esperado (latência para o sono: 9 min; normal até 30 min). A latência para o estágio REM estava alongada (296 min; normal: 70 a 120 min). O sono foi fragmentado pelos despertares longos (eficiência do sono: 67,2%; normal: 85% ou acima) e microdespertares (índice: 90,1/hora; normal até 15/hora). Houve o aumento da porcentagem do estágio 1 (51,1%; normal: 8-10%) e a redução do estágio REM (3,1%; normal: 20%). A porcentagem do estágio 2 (45,8%; normal: 45-55%) permaneceu nos limites da normalidade. Ausência do estágio 3 (0%; normal: 10-12%).

O índice de movimentos periódicos de membros (2,8/hora; índice normal até 15/hora) permaneceu no limite da normalidade. Observei também movimentos de pernas após despertares.

Escala de Sonolência de Epworth: 17 (sonolência diurna; normal até 9; máxima: 24).

Dr. Alberto Jorge Remesar Lopez
Médico
CRM-SP 69.730

Dr. Alberto Jorge Remesar Lopez
Diretor Técnico Médico
CRM-SP 69.730